

Trastorno de Pánico

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El Trastorno de Pánico se caracteriza por crisis de pánico recurrentes e inesperadas, seguidas de al menos un mes de preocupación persistente por nuevas crisis o sus consecuencias. El modelo de Clark (1986) propone que la **interpretación catastrófica de sensaciones corporales** es el mecanismo central de mantenimiento.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación del ciclo pánico Explicar el ciclo: sensación → interpretación catastrófica → ansiedad → más sensaciones. Normalizar la respuesta de lucha/huida. Desmitificar el 'peligro' de las sensaciones (desmayo, infarto, pérdida de control).
2	Inducción interoceptiva Exponer al paciente a sensaciones físicas temidas de forma controlada: hiperventilación voluntaria, girar en silla, respirar por pajita. Objetivo: descondicionar el miedo a las sensaciones. Hacer primero el terapeuta.
3	Reestructuración de interpretaciones catastróficas Identificar el pensamiento catastrófico durante la crisis. Examinar evidencia: ¿alguna vez se desmayó? ¿tuvo un infarto? Calcular la probabilidad real. Generar interpretación benigna alternativa.
4	Respiración diafragmática (con precaución) Enseñar como herramienta de regulación, no como 'escape'. Aclarar que el objetivo es tolerar la sensación, no eliminarla. Evitar que se convierta en conducta de seguridad.
5	Exposición en vivo a situaciones evitadas Construir jerarquía con el paciente. Comenzar por situaciones de menor ansiedad. Permanecer en la situación hasta que la ansiedad baje al menos un 50%. No huir en el pico de ansiedad.
6	Reducción de conductas de seguridad Identificar conductas desseguridad (sentarse cerca de la salida, llevar pastillas, ir acompañado). Explicar cómo mantienen el miedo. Eliminar gradualmente durante las exposiciones.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Identificar conductas de seguridad sutiles (revisar pulso, buscar salidas). Trabajar agorafobia asociada con jerarquía de exposición específica al contexto del paciente.
Adolescentes	Las crisis suelen estar vinculadas a contextos de evaluación o social. Incluir psicoeducación para padres. Evitar el refuerzo de la evitación desde el sistema familiar.
Niños	Poco frecuente antes de los 12 años. Si aparece, usar lenguaje de 'alarma de humo que suena sin incendio'. Siempre evaluar contexto familiar y posible trauma.

Trastorno de Pánico

TCC — Ficha clínica

Clave clínica: La exposición interoceptiva es el componente más potente. Sin ella, el tratamiento es incompleto. El terapeuta debe demostrarla primero.